LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC VÀ CHĂM SÓC DINH DƯỠNG TẠI CỘNG ĐỒNG

ThS. BSNT. Phan Thị Bích Hạnh

MỤC TIÊU HỌC TẬP

1. Trình bày được các khái niệm và hình thức lập kế hoạch truyền thông
2. Trình bày được các bước lập kế hoạch truyền thông giáo dục và chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng
3. Trình bày được các bước triển khai kế hoạch truyền thông giáo dục và chăm sóc dinh dưỡng tại cộng đồng.

- Bạn thường lập kế hoạch gì?

- Hãy kể về ít nhất 2 lần lập kế hoạch mà bạn đã từng tham gia? Theo bạn, đó là loại kế hoạch gì?

- Lập kế hoạch là gì?
- Tại sao phải lập kế hoạch?

Khái niệm – Lập kế hoạch

- Xác định các vấn đề tồn tại và nhu cầu của cộng đồng
- Phân tích xác định các biện pháp có thể đề phòng và kiểm soát các vấn đề này,
- Dựa vào nhu cầu & phân bổ nguồn lực. Đề ra các hoạt động cụ thể để đạt các mục tiêu.

Phân loại

Phân loại theo cách tiếp cận

- ✓ *Lập kế hoạch từ trên xuống*
- ✓ *Lập kế hoạch từ dưới lên*

Phân loại

Có một số cách lập kế hoạch khác dựa vào:

- Phân loại theo thời gian : lập kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
- Phân loại theo qui mô: lập kế hoạch vi mô và lập kế hoạch vĩ mô.

Mục đích lập kế hoạch truyền thông

- Là một quá trình xác định cái gì sẽ phải làm? Làm như thế nào?
- Nó là một quá trình hành động hình thành bởi hàng loạt các hoạt động để đạt được các mục tiêu đáp ứng cho nhu cầu cộng đồng.
- Lập kế hoạch chương trình truyền thông là một quá trình đề ra mục tiêu và tìm các biện pháp để đạt được mục tiêu.

Chu trình lập kế hoạch

- Số liệu
- Nguồn số liệu
- Đánh giá nhu cầu

Phân tích tình hình

Các thông tin cơ bản

Quần thể huyện/xã	Cơ cấu dân số theo tuổi, giới, độ tuổi sinh sản, ...
Tình trạng sức khỏe	Dinh dưỡng, mô hình bệnh tật, tử vong
Nguồn lực y tế	Cơ sở vật chất, nhân lực, tài chính
Chương trình y tế (các CT mục tiêu)	CSSK SS Chăm sóc trẻ em, lâm sàng Sức khỏe môi trường,...

B. Nhân lực

Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Số cán bộ cần Số đang làm

Số bà đỡ trong huyện Số bà đỡ được đào tạo

% được đào tạo

Cơ sở điều dưỡng

Số y tá chuyên nghiệp cần

Số y tá đang làm

%

Số y tá đa khoa cần

Số y tá đa khoa đang làm

%

Số bác sỹ cần

Số bác sỹ đang làm

%

Số phòng thí nghiệm và chuyên gia kỹ thuật cần

Số đang làm

%

Xác định các vấn đề sức khoẻ

- **Vấn đề sức khoẻ là gì?**
  1. Tình trạng yếu kém so với mong đợi/mức trung bình của khu vực, quốc gia.
- **Ví dụ:**
  1. Tỷ lệ suy dinh dưỡng
  2. Hiểu biết của vị thành niên tại huyện A.về SKSS thấp (tỷ lệ/số người có kiến thức cơ bản về SKSS thấp, theo kết quả điều tra KAP năm 2015)
  3. Tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS

Như vậy muốn kết luận một vấn đề, chúng ta cần xem xét thông tin từ những góc độ nào?

Xác định vấn đề ưu tiên

- **Tại sao cần xác định ưu tiên?**
- **Các phương pháp để xác định vấn đề ưu tiên?**

Nguyên tắc:

- Cần có sự tham gia của các bên liên quan
- Cần lựa chọn và thống nhất các tiêu chí để lựa chọn ưu tiên

Xác định ưu tiên

- Vì sao phải xác định ưu tiên?

– Nguồn lực có hạn cần phải được phân bổ theo thứ tự hệ thống ưu tiên

- Phương pháp
  - Xác định nhóm quần thể có nguy cơ lớn nhất
  - Xác định vấn đề sức khỏe quan trọng nhất

Phương pháp xác định ưu tiên

1. Phương pháp nhu cầu (Demands)
2. Phương pháp đánh giá dựa trên sự cần thiết (needs)

- Dựa vào điều tra nhanh, khảo sát hoặc ý kiến chuyên gia

Phương pháp xác định ưu tiên

3. Phương pháp ma trận

- Công cụ thực tiễn và đơn giản
- Có thể áp dụng ở bất kỳ môi trường nào
- Sử dụng các nhóm khác nhau sẽ được sắp xếp ưu tiên theo vấn đề sức khỏe và vấn đề dịch vụ y tế

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ ƯU TIÊN

Vấn đề có điểm cao hơn sẽ được chọn ưu tiên để giải quyết

	Tác động, tính khẩn cấp	**Tính khả thi**	**Phù hợp về chính sách**	**Mong đợi của cộng đồng**	**Chấp nhận về đạo lý**	**Khác (nếu có)**

Điểm: 1= thấp; 2= trung bình; 3= cao

Các tiêu chí để xác định ưu tiên

1. Mức độ tác động hoặc tính khẩn cấp
2. Tính khả thi (nguồn lực: nhân lực, ngân sách, TTB, thời gian)
3. Phù hợp với chính sách của Nhà nước, địa phương, nhà tài trợ...
4. Đáp ứng mong đợi của cộng đồng
5. Chấp nhận được về đạo lý (quyền lợi của các nhóm, văn hoá...)
6. Kết quả bền vững (tiếp tục được duy trì khi dự án kết thúc)

Xác định ưu tiên theo hệ thống thang điểm cơ bản

Vấn đề	Phạm vi (A)	Trầm trọng (B)	Hiệu quả (C)	Kết quả điểm (A+2B)xC
Thừa cân- béo phì	**8**	**10**	**10**	**280**
Suy dinh dưỡng	**9**	**9**	**9**	**243**
Thiếu vi chất	**10**	**8**	**4**	**104**

Chấm điểm cho các yếu tố

- **Yếu tố A: Phạm vi vấn đề:**
  - được thể hiện bằng sự tác động của vấn đề lên số người trong quần thể (số KHàng/BNhân, hoặc số nhân viên bị tác động bởi vấn đề đó..v..v..)
- **Yếu tố B: Mức độ nghiêm trọng vấn đề:**
  - Tính cấp bách
  - Sự thiệt hại về kinh tế, sức khoẻ
  - Tác động đến nhiều loại ĐTượng khách hàng
- **Yếu tố C: Hiệu quả can thiệp**
  - Chi phí ⇔ Kết quả đạt được
  - Công thức HTC = (A+2B)xC

Xây dựng cây vấn đề.

Phân tích nguyên nhân và hậu quả của vấn đề trọng tâm nhất (hay nổi cộm nhất), để xây dựng cây vấn đề.

- Thực hiện mối quan hệ: “Nhân – Quả”

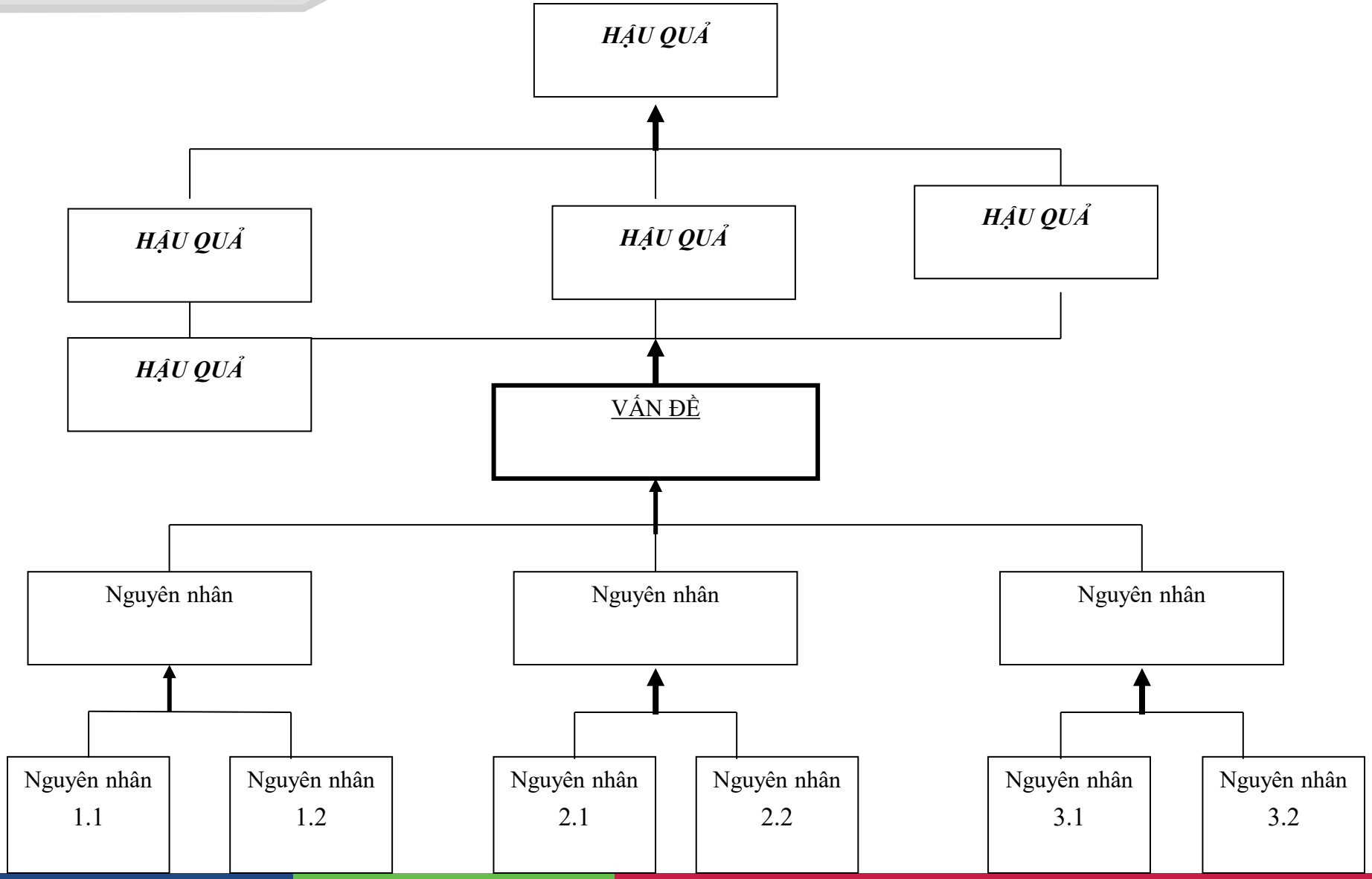
CÁCH XÂY DỰNG CÂY VẤN ĐỀ:

Xác định vấn đề trọng tâm/nổi cộm nhất

- Xem xét các mối liên quan "nhân – quả" trong một sơ đồ (cây vấn đề).

1. Nguyên nhân trực tiếp và quan trọng của vấn đề trọng tâm cần đặt song song nhau bên dưới.
2. Những hậu quả trực tiếp quan trọng đặt song song bên nhau bên trên.

Cây vấn đề


HẬU QUẢ
HẬU QUẢ
HẬU QUẢ
HẬU QUẢ
HẬU QUẢ
VẤN ĐỀ
Nguyên nhân
Nguyên nhân
Nguyên nhân
Nguyên nhân 1.1
Nguyên nhân 1.2
Nguyên nhân 2.1
Nguyên nhân 2.2
Nguyên nhân 3.1
Nguyên nhân 3.2

2.2. Xây dựng mục tiêu

- *Mục tiêu là một tuyên bố về thực trạng mong muốn ở một thời điểm xác định trong tương lai*
- Mục tiêu chung hay mục tiêu dài hạn là mục tiêu với phạm vi lâu dài hoặc một phạm vi rất rộng lớn. Đó là tuyên bố về những điều mong đợi chung sẽ đạt được.
- Ví dụ:“Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi

- Mục tiêu cụ thể: là những mong đợi làm giảm một vấn đề trong tương lai ví dụ như tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ thiếu máu, thiếu vitamin A hoặc mong đợi cải thiện một tình trạng như vệ sinh thức ăn đường phố, ngộ độc thức ăn.

“Giảm tỷ lệ ngộ độc thức ăn xuống 10 % so với tỷ lệ hiện mắc vào năm 2009”.

- Tiêu chuẩn của một mục tiêu tốt: SMART

- *Cụ thể* (Specific)*:* Mục tiêu cần chỉ rõ ai hoặc cái gì cần làm cho thay đổi và thay đổi cái gì (Nhận thức/Thái độ/Thực hành).

- *Đo lường được* (Measurable)*:* Mục tiêu cần chỉ rõ số lượng các chỉ số, tỷ lệ của sự thay đổi mà chúng ta mong đợi.

- *Thích đáng* (Appropriate)*:* Mục tiêu cần có độ nhạy liên quan tới nhóm đối tượng đích và phải là điều mà người ta mong đợi cũng như xã hội mong đợi.
- *Khả thi* (Realistic)*:* Mục tiêu phải đặt ra sao cho nằm trong khả năng có thể đạt được trong một điều kiện cụ thể.
- *Khung thời gian* (Time - bound)*:* Mục tiêu cần chỉ ra khung thời gian cụ thể để đạt được sự thay đổi đó.

SMART GOALS

- **S** • Specific
- **M** • Measurable
- **A** • Achievable
- **R** • Realistic
- **T** • Timely

- Ví dụ: Sau khi kết thúc Dự án Truyền thông thay đổi hành vi dinh dưỡng sẽ có:

- 80% các bà mẹ có con <5 tuổi ở 10 tỉnh thuộc vùng dự án nguồn lực được tăng cường nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ.
- 70% các bà mẹ có con <5 tuổi ở 10 tỉnh thuộc vùng dự án nguồn lực thực hiện cho con bú đúng cách và hoàn toàn trong 6 tháng sau khi sinh.

2.3. Xác định hành vi đích cần thay đổi:

- Dựa trên mục tiêu chung của chương trình/dự án và bước phân tích vấn đề, chúng ta lựa chọn hành vi đích cần thay đổi.
- Hành vi đích này phải là điều mà chúng ta mong đợi, bản thân đối tượng sẵn sàng muốn thay đổi và xã hội chấp nhận, khuyến khích sự thay đổi đó.

2.4. Xác định kênh truyền thông thích hợp

- Có thể cùng một nhóm đối tượng, nhưng có thể có nhiều kênh tiếp cận thích hợp cho mỗi nhóm nhỏ
- Sự sẵn có của cơ sở hạ tầng về truyền thông cũng là một yếu tố đáng quan tâm để quyết định đưa ra kênh truyền thông thích hợp
- Cần nhấn mạnh rằng, sự phối hợp của nhiều kênh truyền thông sẽ phát huy được hiệu quả hơn và sẽ bảo đảm bao phủ được nhiều đối tượng hơn.

2.5. Xây dựng các biện pháp can thiệp (các giải pháp, các hoạt động)

- Biện pháp là quá trình hành động cần thiết phải thực hiện/ tiến hành để đạt được mục tiêu.
- Có nhiều cách để đạt được mục tiêu, người quản lí cần suy nghĩ kĩ về các giải pháp thay thế nhau và chọn một giải pháp hoặc phối hợp các giải pháp tối ưu nhất.
- Có thể liệt kê các ưu điểm, nhược điểm của mỗi giải pháp, giá thành, khả năng thực thi.... trên một ma trận để chọn lấy giải pháp tối ưu.

- Trước khi lựa chọn các biện pháp tối ưu nên chú ý phân tích các yếu tố nguy cơ.
- Phân tích nguy cơ là xác định một cách hệ thống:

+ Các yếu tố thuận lợi,

+ Các hạn chế,

+ Những cản trở ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch

2.5.1. Tiêu chuẩn lựa chọn can thiệp

- Phù hợp: Tiềm năng của can thiệp có giải quyết được vấn đề dinh dưỡng và VSATTP ở cộng đồng?
- Khả năng thực thi: Can thiệp được thực hiện liệu có thành công?
- Lồng ghép được với một chương trình hiện có tương tự: cho phép lồng nghép với can thiệp khác đang tồn tại mà không đòi hỏi xây dựng cấu trúc mới.

- Hiệu quả: Can thiệp có đạt được mục tiêu?
- Có khả năng tới nhóm đích
- Chi phí- hiệu quả: Cho phép tính đến chi phí cho một đối tượng đích liên quan đến đầu ra.
- Khả năng đánh giá: Có khả năng đánh giá được tác động của can thiệp.
- Tính bền vững: Can thiệp đó có thể trở thành công việc lâu dài hoặc chương trình có thể tiếp tục được không?

2.5.2. Phát triển kế hoạch hoạt động

- Đây sẽ là phần chính của chương trình/dự án can thiệp, là những gì chúng ta thực sự làm trong giai đọan triển khai các hoạt động của dự án.
- Những đầu ra, những sản phẩm rõ rệt của dự án cần liên quan với các hoạt động một cách rõ ràng.
- Đầu ra phải đóng góp cho một trong những mục tiêu cụ thể đã được xác định và cũng đóng góp cho mục tiêu chung nhất.

- ***Một hoạt động là bất kì một hành động nào được thực hiện góp phần vào đạt được mục tiêu***
- Như vậy mỗi hoạt động phải đưa đến một sản phẩm và sản phẩm đó phải đóng góp cho một trong những mục tiêu cụ thể đã được xác định.
- ***Sản phẩm là đầu ra của một hoạt động hoặc của một loạt các hoạt động.***

- Một ***hoạt động*** được xây dựng tốt khi đề cập ít nhất đến : Hành động, nội dung, nhóm đích và thời gian.

Ví dụ “Mở 4 lớp tập huấn về VSATTP cho các nhân viên cơ sở ăn uống công cộng trong năm 2002 ”,

Yêu cầu trong bảng xây dựng kế hoạch hoạt động:

- Liệt kê các hoạt động chi tiết cho mỗi biện pháp đòi hỏi.
- Xác định thời gian biểu cho mỗi hoạt động và phân công con người hoặc cơ quan có trách nhiệm thực hiện các hoạt động đó.
- Xác định nguồn lực cho mỗi hoạt động ước tính chi phí và xác định nguồn tiền.
- Hoàn thiện bảng các hoạt động, thời gian, trách nhiệm và nguồn lực đòi hỏi.

- Dựa trên cơ sở bảng danh mục các hoạt động và sản phẩm dự kiến thì đầu vào cần thiết có thể xác định được.
- *Đầu vào là số lượng các nguồn lực như nhân lực, vật lực, tiền và thời gian đưa vào dự án hoặc chương trình can thiệp.*

- *Kết quả là thành quả đạt được cuối cùng của dự án hay chương trình* can thiệp. Ví dụ “Giảm tỷ lệ tử vong do ngộ độc thức ăn”, “*Cải thiện k*iến thức thực hành về VSATTP cho người tiêu dùng tại Tỉnh Y”.

- Để thẩm tra mục tiêu hay hoạt động người ta dùng Chỉ tiêu:
- *Chỉ tiêu là sự mô tả số lượng kết quả mong đợi cuối cùng của một mục tiêu hay hoạt động tại thời gian nêu ra trong tương lai.*

- Các chỉ tiêu nên sử dụng để đánh giá mục tiêu cụ thể của dự án hoặc sản phẩm/đầu ra có đạt được không về các phương diện: Đối tượng, số lượng, chất lượng, thời gian, vùng, cho ai, bao nhiêu, như thế nào, từ bao giờ đến bao giờ, ở đâu.
- Ví dụ:80 % các bà mẹ mang thai và có con dưới 5 tuổi có thực hành đúng về NCBSM vào cuối năm 2009.

Khi lập kế hoạch hoạt động cần trả lời được các câu hỏi sau :

- Hoạt động nào? Cho ai?
- Bao nhiêu? Ai làm?
- Bằng cách nào? Khi nào?
- Bao lâu? Với nguồn lực nào?
- Làm thế nào để theo dõi và đánh giá?
- Tổ chức như thế nào? Ở đâu?
- Khi kết thúc thì báo cáo cho ai?

- Trong kế hoạch hoạt động cần phải trình bày rõ ràng trình tự từ mục tiêu đến sản phẩm, các hoạt động và các chỉ tiêu

Sơ đồ Gantt / kế hoạch thời gian

Hoạt động

Tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mục tiêu 1

Giải pháp 1

Hoạt động 1

Hoạt động 2 …

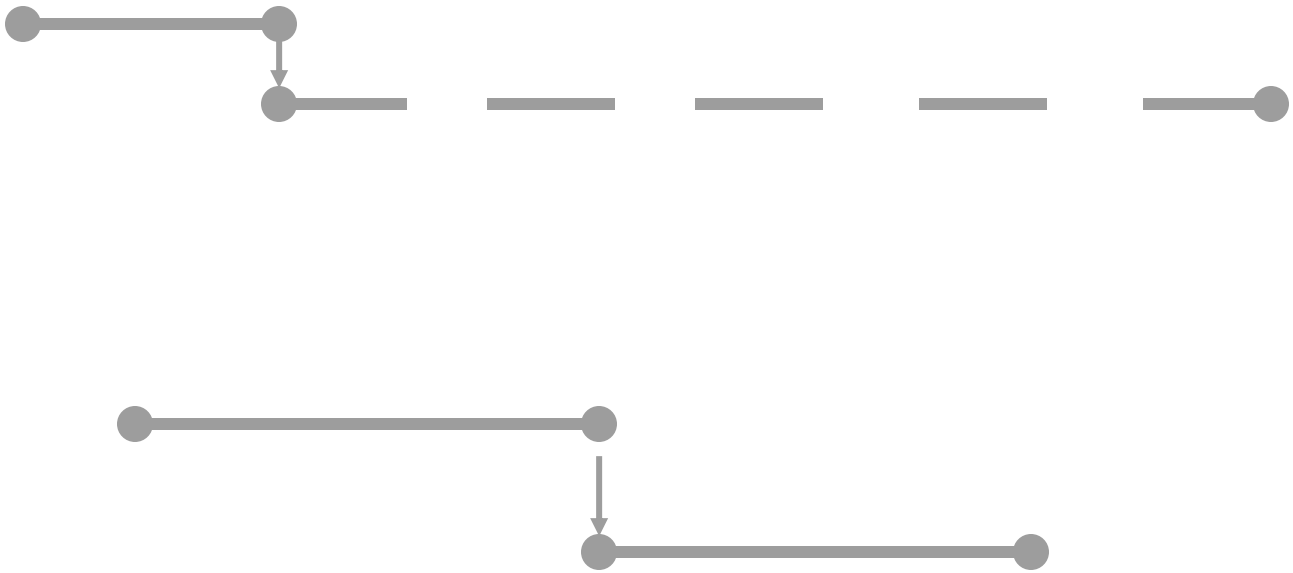
Mục tiêu 1

Giải pháp 2

Hoạt động 1

Hoạt động 2 …

Mục tiêu 2



Kế hoạch triển khai

Tên hoạt động	Năm 2014 Quí 1 Quí 2 Quí 3	Năm 2015	Người chịu trách nhiệm
1.			
2.			

Dự trù kinh phí

STT	Hoạt động	Kinh phí	Nguồn kinh phí
1. **2.** **3.**			**Từ địa phương** **Trung ương** **Chương trình** **Doanh nghiệp**

3. Triển khai kế hoạch truyền thông

- Triển khai các nội dung của kế hoạch
- Tổ chức sản xuất, in ấn các tài liệu/vật liệu truyền thông
- Phát hành qua các kênh truyền thông phù hợp
- Tập huấn sử dụng
- Vận động những nhân vật có ảnh hưởng

3.1. Thiết kế và thử nghiệm trước các tài liệu truyền thông:

- *3.1.1. Thiết kế các loại tài liệu truyền thông* để chuyển các thông điệp tới nhóm đối tượng qua kênh truyền thông thích hợp đã được xác định, như thiết kế tờ rơi, áp phích, băng video, các chương trình quảng cáo trên ti-vi.
- Một yêu cầu cơ bản của quá trình này là cần có sự tham gia của cộng đồng

3.1.2. Tổ chức in hoặc sản xuất thử để mang đi thử nghiệm ở cộng đồng.

- Thu thập khách quan các ý kiến phản hồi để có sự điều chỉnh phù hợp, có thể cần tới 2 bước thử nghiệm.
- Bộ công cụ thử nghiệm phải được chuẩn bị bởi chuyên gia truyền thông có kinh nghiệm

Những yếu tố cần quan tâm:

- Các đánh giá ở bước thử nghiệm không chỉ về mặt nội dung, hình thức mà còn phải xem xét đến các yếu tố văn hóa, xã hội có phù hợp không?
- đối tượng có hiểu đúng ý nghĩa của thông điệp không?
- liệu có còn cách nào chuyển tải tốt hơn thông điệp đến nhóm đối tượng không?

3.2. Sản xuất tài liệu

- Làm sao cân đối được giữa yêu cầu chất lượng và giá thành. Tài liệu truyền thông đóng góp một phần rất lớn cho sự thành công của hoạt động truyền thông dinh dưỡng

3.3. Đào tạo

- Các nhân viên truyền thông là một bước không thể thiếu. Một tài liệu truyền thông mới được sản xuất cần phải được hiểu thấu đáo từ chính nhân viên y tế hoặc cán bộ làm công tác truyền thông (như Cộng tác viên, cán bộ Hội phụ nữ...),

3.4. Vận động những nhân vật có ảnh hưởng

- Họ sẽ trở thành những nhân tố tích cực thúc đẩy nhanh quá trình thay đổi của nhóm đối tượng đích,
- Nếu chúng ta bỏ qua có thể chính họ sẽ là các rào cản quan trọng làm cho chúng ta khó đạt được mục tiêu thay đổi hành vi cho nhóm đối tượng đích.

3.5. Sự phối hợp nhiều kênh truyền thông,

- Cùng với việc vận động cộng đồng tham gia một cách tích cực chủ động, là những yêu cầu cơ bản khi triển khai bất cứ một hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng nào ở cộng đồng.
- Trong quá trình triển khai,cần có những điều chỉnh phù hợp để bảo đảm thành công cho các hoạt động can thiệp.

4.1. Tầm quan trọng của theo dõi, giám sát và đánh giá

- Xác định điểm mạnh và điểm yếu trong các chương trình can thiệp.
- Điều chỉnh ngay hoặc giải quyết các vấn đề tồn tại.
- Đo lường được những tiến bộ không chỉ đối với nỗ lực cải thiện mà còn đối với nỗ lực phát triển, tạo ra và làm nên sự bền vững trong quản lí các chương trình, dự án.

***4.2. Công tác theo dõi, giám sát* được bắt đầu ngay từ khi triển khai chương trình/dự án.**

Cần trả lời được các câu hỏi:

- Chúng ta có bám sát các mục tiêu của kế hoạch đề ra không?
- Sự thay đổi này là do tác động của các hoạt động can thiệp hay do yếu tố tác động nào khác?
- Các bước triển khai của kế hoạch có theo đúng tiến độ không?

THỰC HÀNH

- Nhóm 1: Tăng tỷ lệ ăn sáng của sv Y HN
- Nhóm 2: Cho trẻ ăn dặm
- Nhóm 3: Bổ sung sắt và Acid Folic cho phụ nữ mang thai
- Nhóm 4: Cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn 6 tháng đầu